

個別症例安全性報告

報告ID：ICSR-2025-003

報告種別：自発報告、医療専門家

報告日：2026-01-20

報告者：横浜循環器研究所 鈴木医師

報告者資格：医師（循環器専門医）

発生国：日本

MedDRAバージョン：27.0

患者情報

患者イニシャル：H.N.

年齢：74歳

性別：男性

体重：68 kg

身長：165 cm

人種：アジア人

既往歴・合併症

- ・持続性心房細動（2022年診断、CHA2DS2-VAScスコア4）
- ・冠動脈疾患（2021年、左前下行枝への薬剤溶出性ステント留置による経皮的冠動脈インターベンション施行後）
- ・左室駆出率の保たれた心不全（HFpEF、駆出率55%）
- ・本態性高血圧（長期罹患）
- ・慢性腎臓病ステージ3a（ベースラインeGFR 52 mL/min/1.73 m2）
- ・2型糖尿病（良好にコントロール）
- ・軽度認知障害（2024年に指摘）

被疑薬

薬剤1（主被疑薬）：DrugZ

有効成分：Compound-Z 200 mg

製造販売業者：Pharma Sample Co., Ltd.

剤形：錠剤

用法・用量：開始時 200 mg 1日2回を7日間、その後 200 mg 1日1回で維持

投与経路：経口

適応：心房細動における洞調律維持

投与開始日：2025-09-10

投与終了日：2025-12-28

薬剤に対する処置：投与中止

薬剤2（併合被疑薬）：ワルファリン

用法・用量：3 mg 1日1回（INRに応じて用量調整、変動あり）

投与経路：経口

適応：心房細動における脳卒中予防

投与開始日：2022-06-01

投与終了日：継続中（用量調整実施）

薬剤に対する処置：減量

併用薬（継続中）

- ・カルベジロール 6.25 mg 1日2回（2022年より継続）

- ・アスピリン 100 mg 1日1回 (2021年より継続)
- ・アトルバスタチン 40 mg 1日1回 就寝前 (2021年より継続)
- ・フロセミド 20 mg 1日1回 (2024年より継続)
- ・エンパグリフロジン 10 mg 1日1回 (2023年より継続)
- ・ドネペジル 5 mg 1日1回 (2024年より継続)

有害事象

事象1：INR増加 (International normalised ratio increased)

発現日：2025-10-12

ピーク値：INR 5.8 (目標範囲 2.0～3.0)

転帰：用量調整後に回復

重篤度：非重篤

事象2：鼻出血 (Epistaxis、反復性)

発現日：2025-10-14

転帰：回復

重篤度：非重篤

事象3：斑状出血 (Ecchymosis、両側上肢の広範な皮下出血)

発現日：2025-10-15

転帰：回復

重篤度：非重篤

事象4：徐脈 (Bradycardia、症候性)

発現日：2025-11-22

最低記録心拍数：38 bpm

転帰：投与中止後に回復

重篤性の該当基準：入院

重篤度：重篤

事象5：失神 (Syncope)

発現日：2025-11-22

転帰：回復

重篤性の該当基準：入院

重篤度：重篤

事象6：起立性低血圧 (Orthostatic hypotension)

発現日：2025-11-23

転帰：回復

重篤度：非重篤

事象7：錯乱状態 (Confusional state)

発現日：2025-12-15

転帰：回復

重篤度：非重篤

事象8：浮動性めまい (Dizziness)

発現日：2025-12-15

転帰：回復

重篤度：非重篤

因果関係評価

事象1～3（出血関連）について：

報告者による因果関係（DrugZ）：ほぼ確実（Probable）

報告者による因果関係（ワルファリン）：可能性あり（Possible）（DrugZとの相互作用が疑われる）

WHO-UMC判定：薬物相互作用についてほぼ確実（Probable）

事象4～6（心臓／血行動態関連）について：

報告者による因果関係（DrugZ）：ほぼ確実（Probable）

WHO-UMC判定：ほぼ確実（Probable）

事象7～8（神経学的）について：

報告者による因果関係（DrugZ）：可能性あり（Possible）

WHO-UMC判定：可能性あり（Possible）

症例経過

74歳男性。持続性心房細動、冠動脈疾患、左室駆出率の保たれた心不全、高血圧、慢性腎臓病ステージ3a、2型糖尿病、および軽度認知障害の長期にわたる既往を有し、当院にて心血管管理を受けていた。心房細動に対しては2022年よりカルベジロールによるレートコントロール（心拍数調節）を行い、ワルファリンによる抗凝固療法をINR目標範囲2.0～3.0で維持していた。ワルファリン3 mg/日の用量で、直近18か月間INR値は安定して推移していた。

2025年9月、症候性の動悸増強および運動耐容能の低下を認めたため、リズムコントロール（洞調律維持）戦略を試みることにし、DrugZ 200 mg 1日2回を7日間の初期負荷投与として追加し、その後維持用量として200 mg 1日1回へ移行した。ベースラインの心電図では、心室応答がコントロールされた（78 bpm）心房細動を認め、QTc間隔は432 msであった。肝機能検査、甲状腺機能検査、および腎機能は、いずれも直近のベースライン範囲内であった。

DrugZ開始から約1か月後（2025-10-12）、定期的なINRモニタリングにて、ワルファリンの用量、食事内容、その他の併用薬に変更がないにもかかわらず、予期せぬINR上昇（5.8）を認めた。患者は新たな一般用医薬品、サプリメント、健康食品の使用を否定し、発熱性疾患の既往もなかった。2日後（2025-10-14）、反復性の鼻出血を発症し、局所圧迫および外来受診を要した。2025-10-15までに、軽微な外傷を契機として両前腕に広範な斑状出血を認めた。ワルファリンを2日間休薬した後、用量を3 mgから1.5 mg/日へ減量したところ、INRは1週間以内に治療域へ復した。本事象の原因として、シトクロムP450阻害（特にCYP2C9およびCYP3A4）を介したDrugZとワルファリンの相互作用が疑われた。

患者はより厳密なワルファリンモニタリングのもと、DrugZを維持用量200 mg 1日1回で継続した。2025-11-22、DrugZ開始から約10週後、患者は浴室からの歩行中に失神発作を起こし、娘に付き添われて救急外来を受診した。来院時、心拍数は38 bpm、血圧は92/58 mmHgであった。心電図では、心室応答が著明に低下した心房細動と、QTc間隔の延長（498 ms、ベースライン432 ms）を認めた。催不整脈作用（トルサード・ド・ポアント）は認められなかった。

患者はテレメトリーモニタリング目的で入院した。入院時にカルベジロールおよびDrugZをいずれも休薬した。その後48時間で心室拍数は60～70 bpmへ徐々に回復し、QTcは460 msへ短縮した。以後、血行動態は安定して経過した。カルベジロールは3.125 mg 1日2回へ減量して再開したが、徐脈の再発は認めなかった。DrugZと既存のβ遮断薬併用療法が過度の陰性変時作用を生じたものと考えられ、これに患者の高齢、腎クリアランスの低下、およびカルベジロール代謝に影響する薬物相互作用の可能性が加わったものと推察された。入院中に軽度の起立性低血圧を認めたが、退院時までに消失した。

2025-11-27に退院した後、患者はDrugZを中止したまま経過した。患者およびその娘との話し合いでは、代替抗不整脈薬の使用と、純粋なレートコントロール戦略への回帰とが検討された。患者の高齢、認知機能の合併症、およびDrugZに対する明らかな感受性を踏まえ、レートコントロール戦略が選択された。

2025-12-15、DrugZ中止から3週間後、患者の娘より、特に午後遅くから夕刻にかけて出現する新規の錯乱エピソードが報告された。患者は時に家族を認識できず、日付が分からなくなることがあったとされる。また、持続する軽度の浮動性めまいも訴えた。DrugZの開始ではなく中止との時間的関連は非典型的であるものの、DrugZは消失半減期が長く（活性代謝物で数週間と推定される）、遅発性の中枢神経系への影響は否定できなかった。患者の既存の軽度認知障害が、直近の入院や薬剤変更により増悪した可能性もある。ドネペジルは変更なく継続した。

本報告日（2026-01-20）までに、錯乱エピソードは約3週間かけて徐々に消失した。浮動性めまいも消失した。患者はDrugZを中止したままであった。ワルファリン3 mg/日（DrugZのウォッシュアウト後に復帰した当初の用量）でINRは安定していた。カルベジロール3.125 mg 1日2回で心拍数は68 bpmであった。失神や出血事象の再発は認められなかった。

薬物相互作用に関する考察（DRUG-DRUG INTERACTION DISCUSSION）

本症例で認められたDrugZとワルファリンの相互作用は、シトクロムP450酵素阻害を介した、これまでに報告されている薬物動態学的相互作用と一致する。DrugZは、S-ワルファリンの代謝を担う主要酵素であるCYP2C9を阻害することが知られており、ワルファリン曝露量の増加とINR上昇をもたらす。併用の際は、綿密なINRモニタリングと、通常30～50%のワルファリン減量を行うべきである。

徐脈事象は、腎クリアランスの低下した高齢患者においてDrugZをβ遮断薬と併用した際の、相加的な陰性変時作用を反映したものである。

追跡調査

2026-02-15に循環器科の追跡受診を予定しており、心電図の再検および臨床評価を行う。DrugZの再投与は予定していない。代替となる抗不整脈薬の選択肢については、症候性の動悸が再発した場合にのみ検討する。